PROTOCOLLO 65

Esercizio eccentrico in chiusura

Migliorare il controllo eccentrico degli abbassatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Chiusura rapida o a scatti
- ✓ Scarso controllo
- ✓ Fase avanzata

Controindicazioni e precauzioni

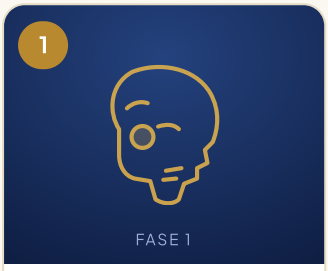
- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura

Apri fino al limite confortevole.



Resistenza

Mano sotto il mento offre una lieve resistenza.



Chiusura lenta

Chiudi lentamente contro la resistenza in 4 secondi.



Rilascio

Rilassa a fine movimento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	8 a 10
Durata	4 secondi per ripetizione
Serie	2

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Controllo della velocità
- ✓ Resistenza lieve
- ✓ Nessun click

Errori da evitare

- ! Velocità elevata
- ! Resistenza eccessiva
- ! Esecuzione con dolore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Chiusura lenta	Chiusura in 4 secondi contro lieve resistenza	8 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il controllo eccentrico migliora la qualità del movimento e riduce i rumori.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.